

Procedimiento de confidencialidad copias acceso y cierre de archivo

Objetivo

Establecer una secuencia verificable para procedimiento de confidencialidad copias acceso y cierre de archivo, articulada con la oferta y los recursos reales del consultorio.

Alcance y responsabilidades

Aplicación en psicología ambulatoria, dentro de competencia y modalidad habilitada. Responsable clínico o del proceso: asignar en la adopción; personal de apoyo actúa según rol y entrenamiento. Confirmar aplicabilidad al prestador y sede antes de adoptar.

Términos de uso

Criterio: condición que se verifica. Evidencia: soporte auténtico de lo realizado. No conformidad: diferencia frente al criterio aplicable. Contención: medida inmediata para impedir daño. Cierre: corrección cuya eficacia se comprobó. Los términos clínicos/técnicos particulares se interpretan conforme a la guía o manual indicado.

Solicitud

Recibir por canal seguro, verificar identidad, calidad del solicitante y finalidad. Distinguir titular, representante, apoyo y autoridad legalmente facultada. No entregar toda la historia por petición de familiar, asegurador, escuela o abogado sin analizar legitimación.

Decisión

Revisar alcance autorizado, base jurídica, datos de terceros y restricciones. Facilitar derechos sin exponer otros usuarios; motivar respuestas y alternativas cuando corresponde. Registrar autorización o causal legal y mínimo necesario.

Entrega

Preparar copia íntegra del alcance permitido, verificar destinatario y usar canal seguro. Dejar constancia de entrega y anexos, sin retirar original de custodia. Gestionar corrección mediante adenda trazable, no borrado del registro clínico.

Conservación y cierre

Aplicar Resoluciones 1995 de 1999 y 839 de 2017; retención general mínima de quince años y excepciones legales. No eliminar automáticamente por vencimiento o solicitud de supresión. Antes de cierre del servicio acordar custodio, transferencia segura y comunicación a usuarios según procedimiento aplicable.

Aplicación paso a paso y respuesta a desviaciones

Registro

Documentar inmediatamente, identificar usuario, fecha, hora y autoría válida. Diferenciar hechos referidos, observaciones e inferencias y explicar incertidumbre. No copiar diagnósticos ni rellenar retrospectivamente sesiones que no ocurrieron.

Integridad

Verificar consentimiento, anexos y coherencia del plan/evolución. Corregir mediante adenda con fecha y autor, conservando original. Proteger datos de terceros y material técnico de pruebas con las reglas aplicables.

Acceso

Verificar identidad y legitimación, mínimo necesario y canal seguro antes de entrega. Conservar original y constancia; revisar conservación y continuidad en caso de cierre de servicio.

Seguimiento

Auditar muestra codificada y autorizada, con criterio y periodo definidos. Registrar incompletitud, corrección y prevención; no circular historias identificables en carpetas administrativas de acceso general.

Frecuencia y puntos de control

Ejecutar en cada atención, tarea o cambio que active este proceso. Definir periodicidad de revisión por riesgo, oferta, fabricante y norma aplicable; registrar la programación local. La periodicidad local no se presenta como exigencia legal universal.

Registros relacionados

Usar los formatos individuales vinculados al código PSI-HC90 en el índice maestro. Asociar fecha, responsable, resultado y ubicación de evidencia. Las historias y consentimientos diligenciados se mantienen en expediente reservado; los soportes administrativos no deben exponer datos clínicos.

Verificación, fundamento y adopción

Indicador y método de evaluación

Indicador local propuesto: ejecuciones verificadas con pasos críticos completos / ejecuciones revisadas × 100. Definir periodo, muestra, fuente y meta según riesgo. Con denominador cero anotar no calculable. Registrar además oportunidad y gravedad de desviaciones; no interpretar ausencia de reporte como ausencia de daño.

Acciones correctivas

Describir hallazgo concreto, medida inmediata, causa, acción, responsable y plazo. Verificar eficacia con evidencia posterior antes de cerrar. Si existe riesgo activo o falta competencia/recurso, suspender la actividad afectada y coordinar alternativa segura.

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes. Criterios generales 11.1 y consulta externa 11.2.1; 11.2.2 para oferta especializada que corresponda. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026; no se aplica su manual como régimen vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Historia clínica y reserva

Resolución 1995 de 1999, artículos 3 a 5 y 11 a 14; Resolución 839 de 2017, conservación y reglas especiales. El diseño sin casillas de firma exige asociar autoría y aceptación válidas antes del uso clínico.

<https://minsalud.gov.co/ihce/Paginas/Normatividad.aspx>

Datos personales

Ley 1581 de 2012 y desarrollo aplicable: finalidad, datos sensibles, derechos y seguridad. Separar consentimiento asistencial de finalidades opcionales.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>

Psicología

Ley 1090 de 2006, ética, competencia, reserva, pruebas y consentimiento. Ley 1616 de 2013 modificada por Ley 2460 de 2025: marco de salud mental con enfoques de derechos y diferencial.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66205>

Soportes auténticos que deben anexarse

Adjuntar documentos de autoridad, títulos/licencias, guías completas, instrucciones del fabricante, contratos o registros reales que correspondan al contenido. No se producen certificados, mantenimientos, planos técnicos ni evidencias de ejecución ficticias.

Adopción y actualización

Completar responsables, recursos, límites y registros; aprobar con autenticación válida y capacitar antes de utilizar. Revisar ante cambio normativo, incidente, tecnología o población. El encabezado permanece vacío para personalización; el contenido es propuesta y no acredita por sí mismo cumplimiento.

Aprobó

Natalia Angel Usuga